

2025 台美衛生福利政策研討會

大家醫計畫

以人為中心之全人全程照護

報告單位：衛生福利部中央健康保險署

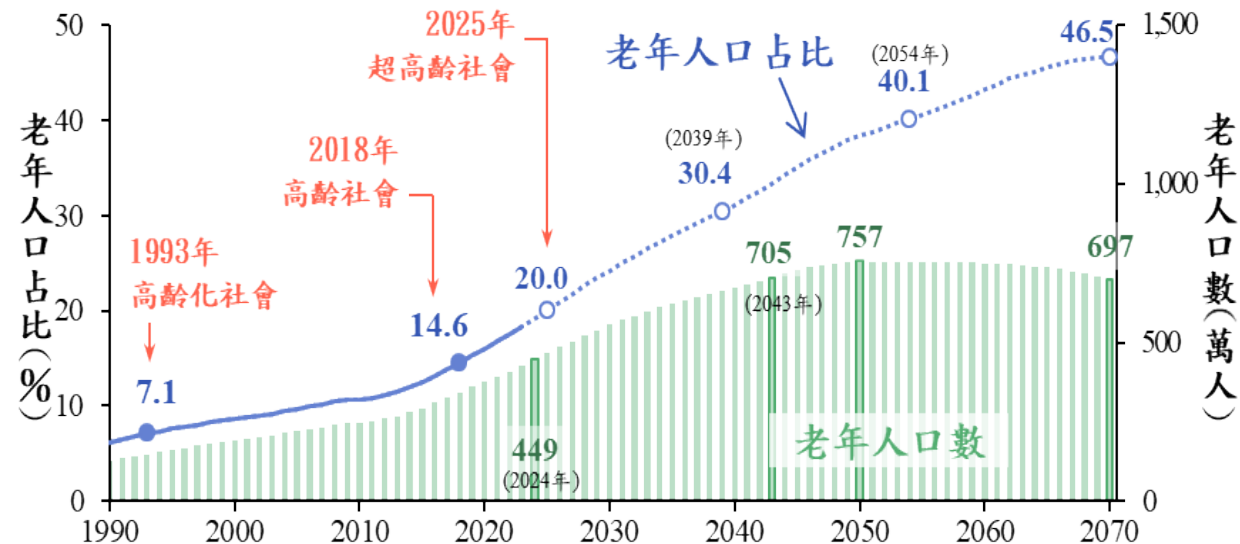
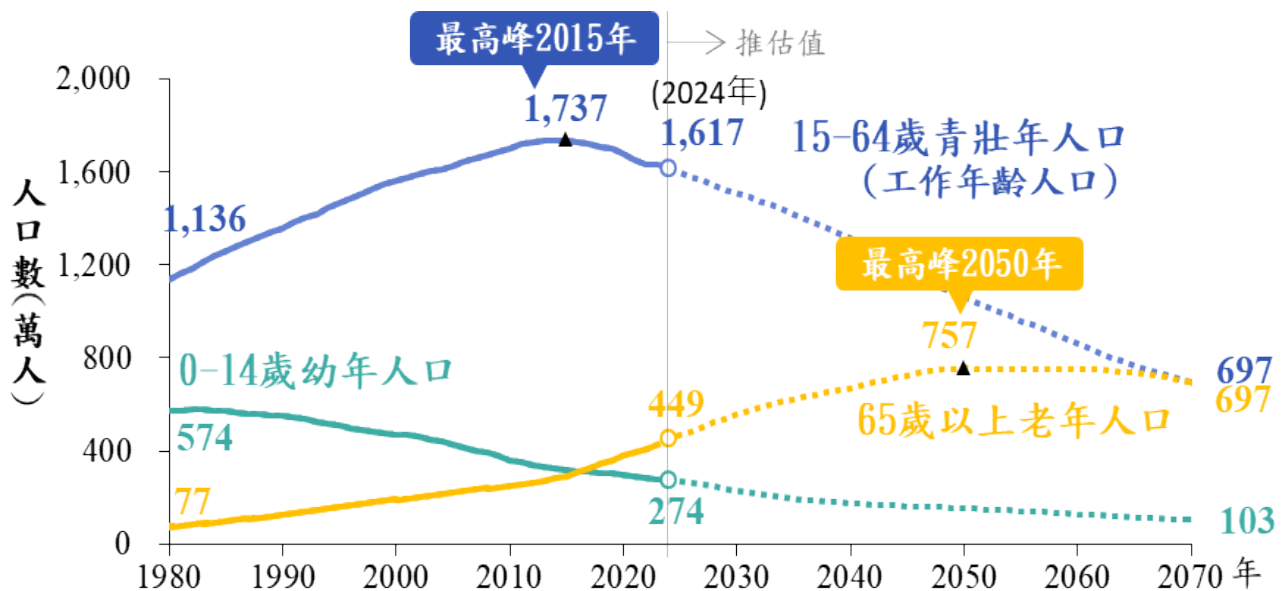
2025.05.06



人口快速老化 2025 邁入超高齡社會

- 幼年人口及青壯年人口分別自 1984 年、2016 年起逐年下滑
- 老年人口至 2050 年達最高峰 757 萬人後，微幅減少
- 老年人口於 2017 年超越幼年人口，2070 年達幼年人口的 6.8 倍

- 我國於 1993 年進入高齡化社會
- 2018 年轉為高齡社會，推估於 2025 年邁入超高齡社會
- 老年人口占總人口比率將持續提高，預估於 2039 年突破 30%，至 2070 年將達 46.5%



備註：1. 幼年人口最高峰時點為 1972 年之 583 萬人，隨後上下波動，並自 1984 年起開始逐年下滑。

2. 2070 年老化指數（老年人口與幼年人口之比）預估將達 678.7，表示老年人口將為幼年人口之 6.8 倍。

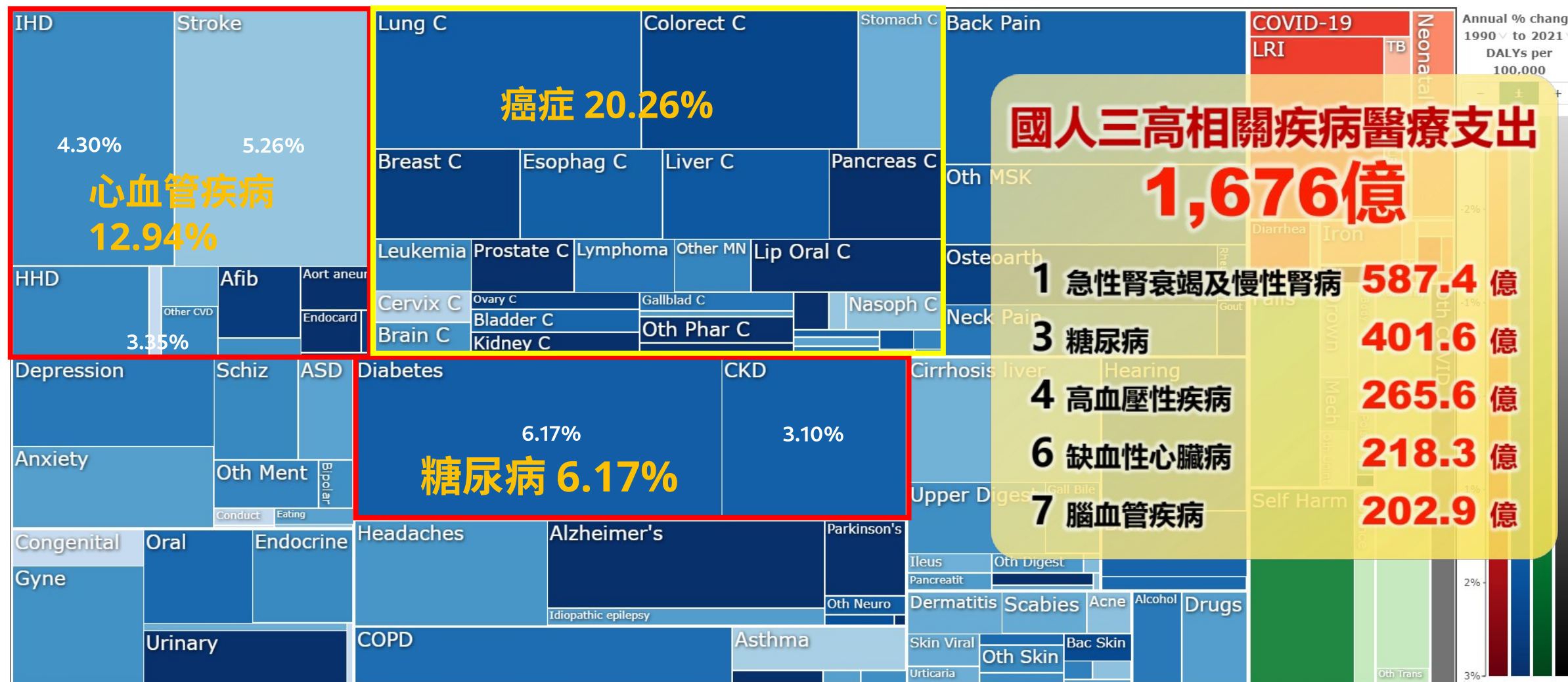
資料來源：國家發展委員會「中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）」，2024 年 10 月。（2023 年（含）以前為內政部「中華民國人口統計年刊」；2024 年（含）以後為該報告之中推估）



癌症及三高疾病為國人最主要的健康負荷

DALYs by Cause in Taiwan, 2021

癌症 20.26% 居冠，**心血管疾病 12.94%** 排第二、**糖尿病 6.17%** 第三



提供以人為中心、全生命歷程的照護服務

初級照護

急性住院

出院
準備

急性後期照護

出院
準備

居家醫療

安寧療護

家庭醫師計畫

疾病治療與控制

- 定期追蹤
- 用藥處方、指導
- 轉診、轉檢
- 緊急諮詢

預防保健

- 疫苗接種
- 疾病篩檢
- 衛生教育

生活習慣介入

- 營養諮詢
- 運動、健康促進
- 自我健康管理



論質計酬計畫

孕產婦周產期
照護

早期療育方案

糖尿病照護整合方案

DKD 照
護

CKD 照
護

BC 肝照
護

氣喘照護

COPD 照護

乳癌照護整合方案

精神疾病照護整合方案

- 住院 PAC
- 居家 PAC

- 居家照護
- 一般居家醫療
- 重度居家醫療
- 安寧居家醫療
- 在宅急症照護
(2024.07.01-)

- 住院安寧
- 安寧共照
- 居家安寧

長照機構醫療服務

- 巡迴診療
- 機構居家照護
- 機構安寧療護
- 減少就醫獎勵方案
- 在宅急症照護 (2024.07.01-)

慢性病照護相關計畫 實施歷程

方案 / 計畫推動目的

- ✓ 自 2001 年起陸續推動各項**醫療給付改善方案 (Pay for Performance, P4P 方案)**，除原有論量計酬，額外提供管理照護費及品質獎勵金等獎勵誘因，鼓勵院所主動定期追蹤病人病情，延緩病程惡化，提升疾病照護品質。**現行共計 11 項 P4P 方案。**
- ✓ 為提供以病人為中心之醫療照護，自 2003 年起試辦**家庭醫師整合照護計畫**，2006 年全面執行。
- ✓ 2022 年實施**代謝症候群防治計畫**，透過早期介入，個案追蹤管理，引導改變飲食及生活型態，進一步預防或延緩慢性病發生。



家醫計畫 建構在地健康照護網路

2024 年
收案數
627 萬人



522 個社區醫療群
診所 5,544 家
醫師 7,949 名

- ▶ 鼓勵同一地區 5 家以上基層診所與合作醫院共同組成「社區醫療群」，以群體力量提供周全性、協調性且連續性的社區醫療服務。
- ▶ 優先將高齡、慢性病、醫療高利用等較需照護之民眾，交付家醫計畫參與診所，提供健康管理。



慢性病照護面臨的問題及困境

涵蓋率及診所參與率不足

- ✓ 家醫計畫收案人數僅占保險對象 25%
- ✓ 家醫計畫診所參與率約 5 成



慢性病人照護品質待加強

- ✓ 2023 家醫會員中，有 104 萬 DM 或 CKD 病人，其中僅 49 萬人被 P4P 收案照護



人口快速老化

共病人數逐年增加

- ✓ 2023 年 65 歲保險對象人數約占 17.7%
- ✓ 2023 年家醫慢性病患者中，30% 為 65 歲以上多重慢性病人



缺乏整合及全人照護

- ✓ 家醫計畫及 P4P 獨立進行，僅提供片段式照護



大家醫計畫 - 實現以人為中心之整合照護

2024 年 執行內容

- **西醫基層一家醫計畫 2.0**：整合 P4P-DM/CKD/DKD 及代謝計畫，讓個案於同診所接受整合性照護
- **地區醫院－全人全社區照護計畫**：將尚未接受照護的**三高病人**交由主要就醫的地區醫院提供預防保健、癌症篩檢、初級疾病治療與衛教之全人全程照護服務

慢性病照護整合

- 以家醫計畫為基礎，逐步**整合各項論質支付方案與慢性病 (NCD) 防治計畫**
- 建立融合三段五級，以人為中心之整合式多重慢性病健康管理模式

支付制度改革

- **論價值支付**，落實有效照護 (effective care) 接軌國際指引，提升民眾健康
- **依據病人風險分級進行分級支付**，避免逆選擇
- 試辦慢性病 **論人計酬 (bundled payment)**



品質指標監測

- 依據證據醫學訂定**醫療品質指標**，監測執行狀況

全方位健康管理

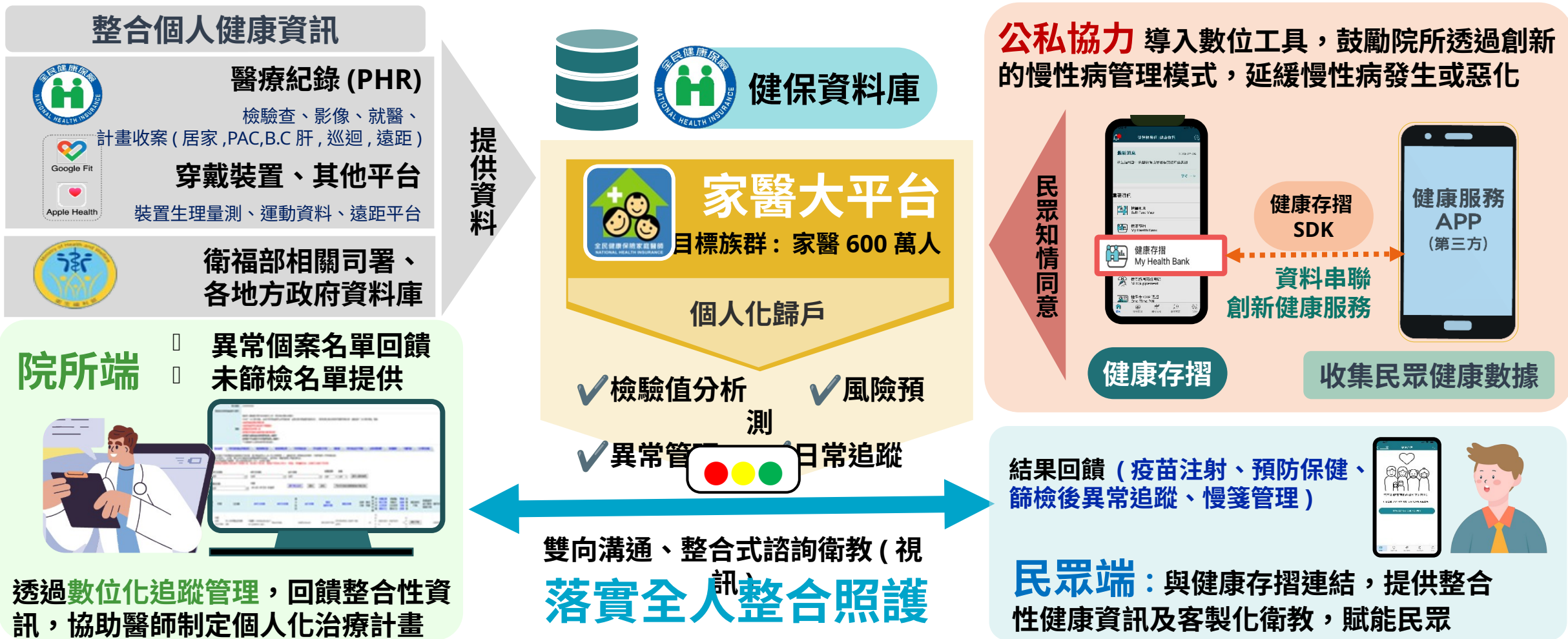
- 包括疾病管理、預防保健、風險因子預防、衛教諮詢等全方位健康管理
- **生活型態介入**，提供後續生活習慣諮商及訂定治療計畫
- 鼓勵醫療群、醫院建立整合式健康管理中心

創新照護模式

- **建構數位平台整合個人健康數據**，提升健康管理效能
- **導入數位工具**（如 APP）透過創新慢性病管理模式，延緩慢性病發生。

家醫大平台 建構個人化初級健康照護 (PHC)

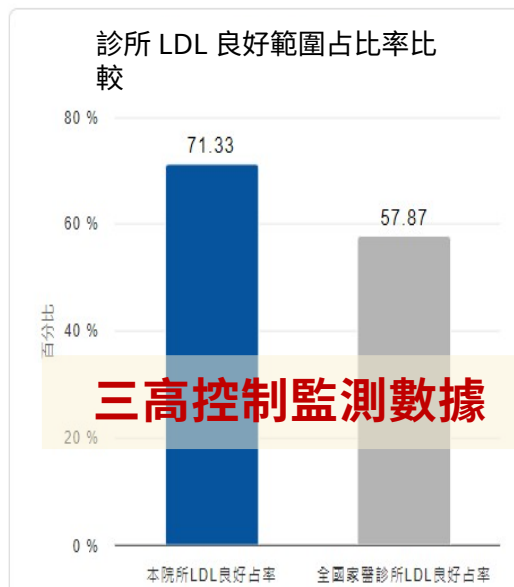
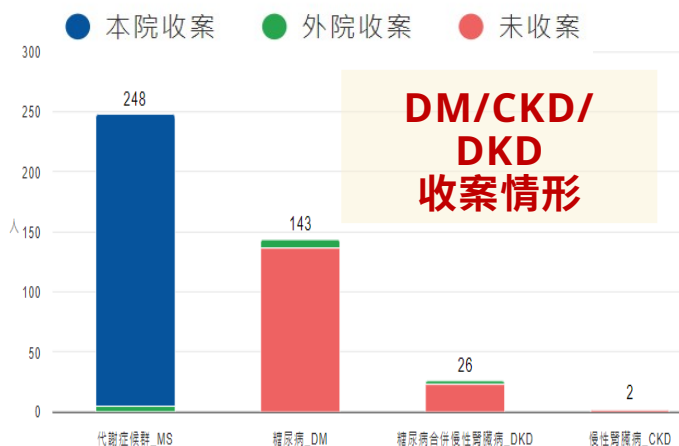
- ▶ 建構個人化初級照護健康管理平台及資料治理架構，**個人化資料歸戶與授權管理**
- ▶ 數位化追蹤管理，回饋醫師個人化資訊，**協助醫師制定治療計畫**
- ▶ 與健保健康存摺連結，回饋整合性個人健康資訊，**賦能民眾**



建構家醫大平台串聯全人照護

建構數位平台整合個人健康數據，強化健康管理效能

- **管理者介面：**整體收案狀況，含 P4P-DM/CKD/DKD 收案及追蹤情形、特定檢驗 (查) 結果、家醫指標表現
- **個案管理介面：**會員健康資料：含 P4P 追蹤及預防保健執行狀況、疾病嚴重度 (ASCVD)、用藥紀錄等



項目	符合篩檢條件	篩檢結果	最後篩檢日	建議下次篩檢日期
成人預防保健	Y	-	2024/02/20	
子宮頸抹片檢查	N			
糞便潛血檢查	Y	無異常	2023/04/15	2025/04/14
BC肝篩檢	Y	已做過	2023/04/15	

預防保健執行狀況



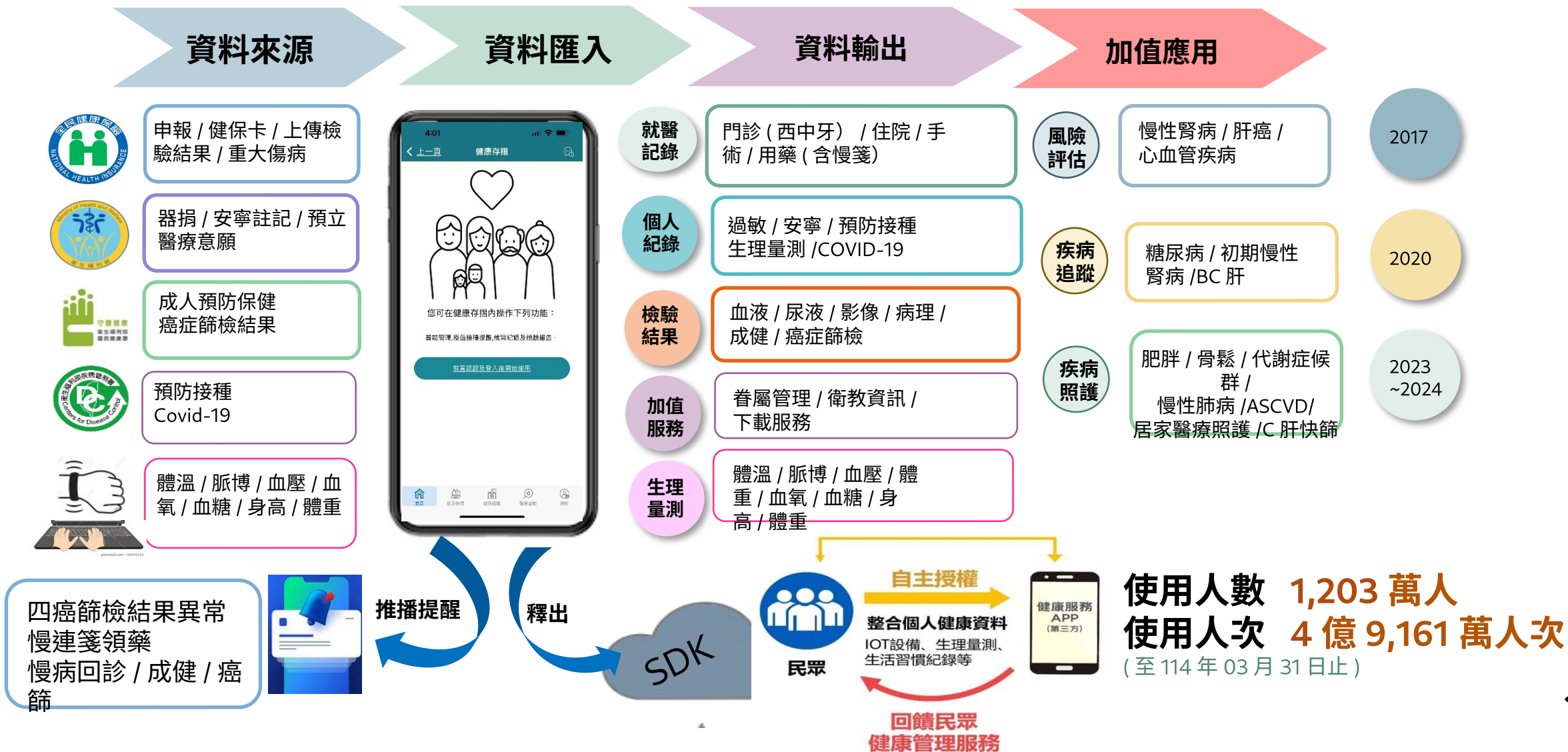
公私協力導入數位工具，透過創新智慧健康照護模式，建立個人化健康照護計畫與衛教，促進健康識能



建立疾病風險分級模型、分流照護機制，並導入價值基礎給付，提升照護品質

健康存摺 單一平台整合個人健康資料

還資於民 強化自主健康管理 2014 年建置健康存摺



規劃動脈粥狀硬化心血管疾病 (ASCVD) 疾病預防及血脂照護模式

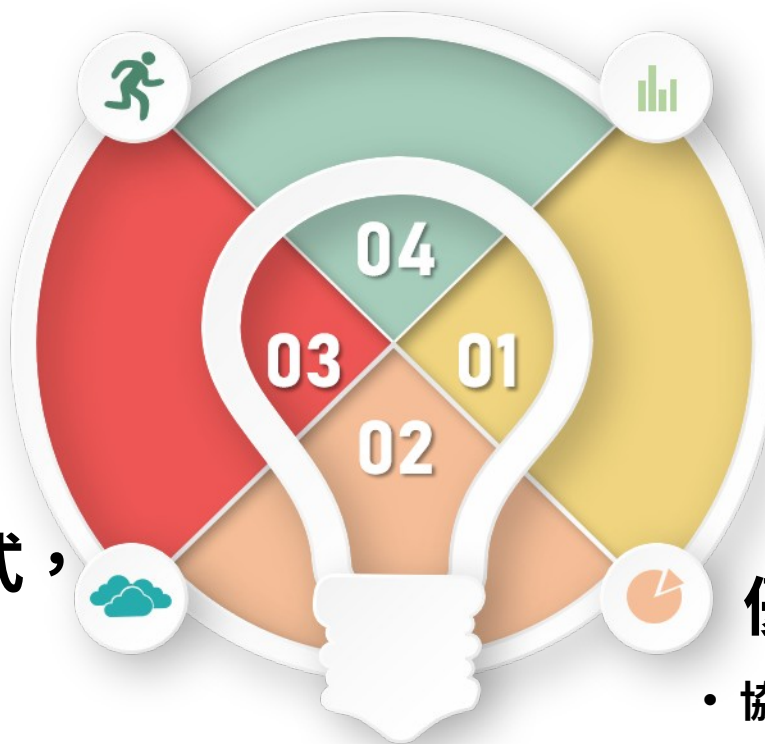
LDL-C 達標率未滿 4 成，檢測執行率尚有改善空間

提升民眾健康識能

- 推廣 ASCVD 預防及治療認知，提升民眾對疾病預防和**自我健康管理**的能力

建立病人辨識及追蹤照護模式， 提升照護效率

- 開發與導入病人辨識與追蹤工具
- 結合健保相關計畫或資訊平台，及時精準識別高風險 ASCVD 個案，銜接**個案追蹤與管理**



數據蒐集與分析，資料整合及 監測

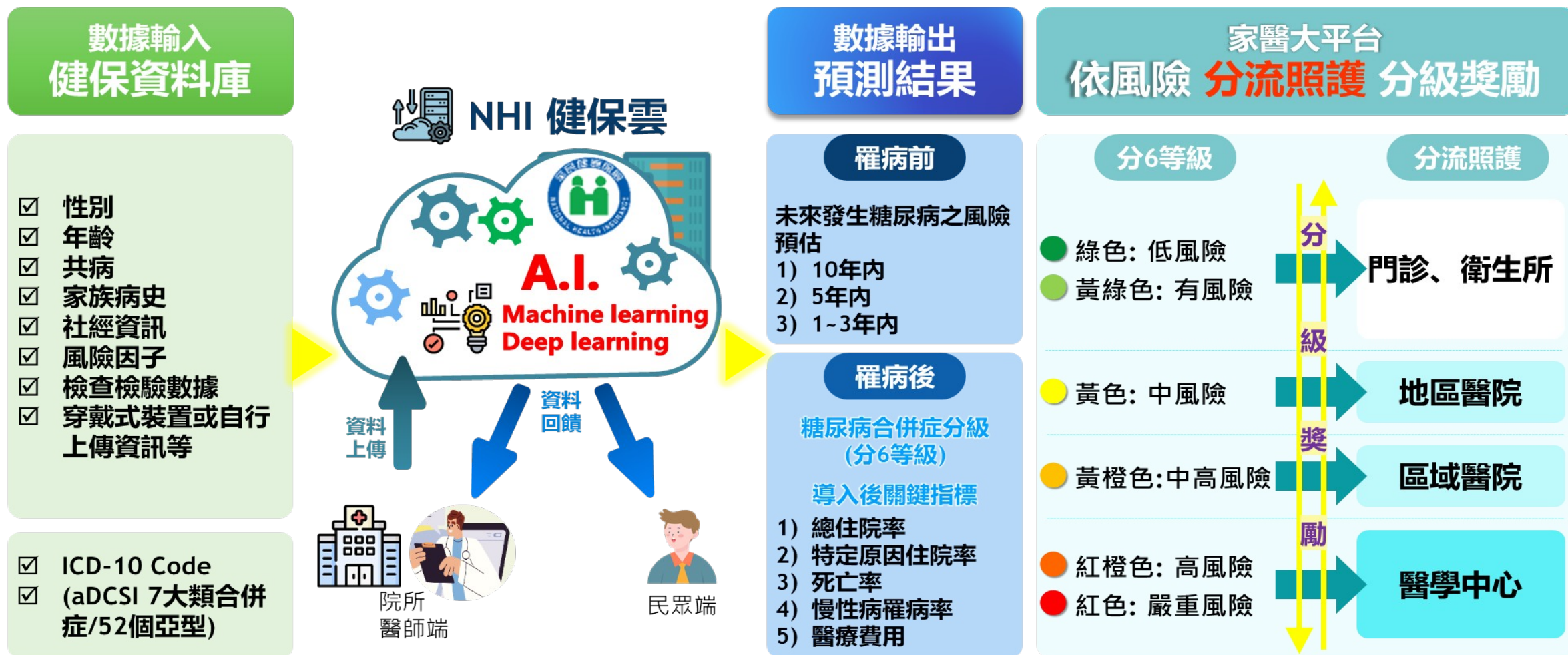
- 分析健保資料，識別疾病現況與趨勢、可控風險因子管理現況
- 建立改善目標

優化並推動血脂管理臨床路徑

- 協同相關學會**更新臨床治療指引**，促進國際接軌
- 將血脂管理臨床路徑融入 **P4P 照護計畫**
- **依血脂管理路徑分階段修訂藥品給付規定。**

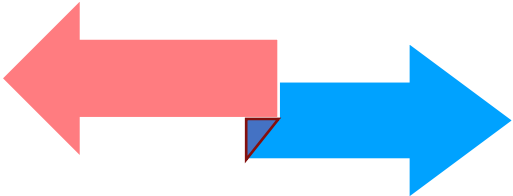
疾病分級分流照護 試辦 DM Bundled Payment

- 透過公私協力，**建構疾病風險分級及預測模型開發**，並結合分級醫療政策與 P4P 給付
- 以**糖尿病為例**，規劃試辦 **Bundled Payment**



可外出
就醫病患

透過**大家醫計畫**
整合社區醫療服務



行動受限
困難外出
就醫病患

推動居家醫療計畫 2.0
無縫銜接長照服務

家庭醫師計畫為基礎，推動**大家醫計畫**
逐步整合慢性病照護計畫及代謝症候群計畫。

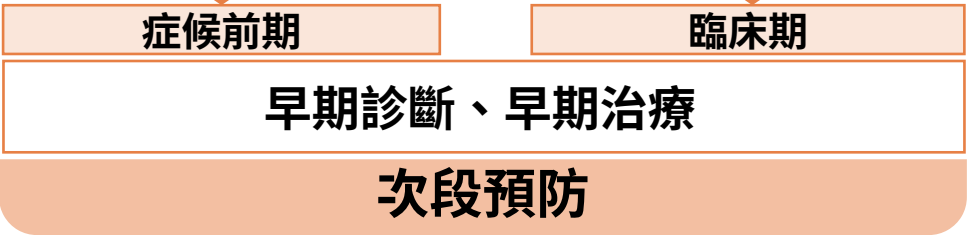
- ✓ 代謝症候群計畫先介入
- ✓ 整合糖尿病照護延緩重症增加
- ✓ 逐步推動慢性病照護論人方案



代謝症候群計畫介



家醫計畫照



居家醫療照護整合計畫 2.0

檢討居整計畫、安寧居家療護，並推動**在宅急症照護**模式，
擴及**長照機構**住民，鼓勵醫療團隊走入社區提供居家醫療
全人全程照護。

結合長照機構住民減少就醫方案
長照服務，逐步**推動論人方案 (ACO)**



擴大全人全程照護

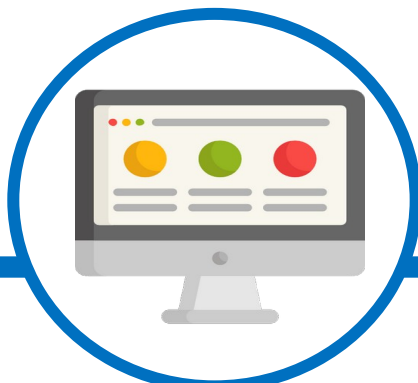
- ▶ 家庭醫師需充分掌握病患完整健康資料（如疫苗施打、預防保健等）
- ▶ 加強政策誘因，導入**在宅急症照護**，銜接長照資源

大家醫計畫整合藍圖



服務更大

家醫計畫為本，逐步納入其他慢性病照護計畫



平台更強

整合會員就醫及健康資料 (PHR)，導入數位化追蹤管理



支付更適

依據疾病風險分流照護、分級獎勵，擴大價值基礎給付



最終目標
逐步落實健保法 44 條：實施家庭責任醫師制度及論人計酬

健康台灣目標：每戶都有家醫！健康家庭、健康台灣



THANK YOU

